

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

JÚLIA JODJAHN FIGUEIREDO

Relação entre manifestações clínicas e o tempo até o diagnóstico da Doença
Inflamatória Intestinal na faixa etária pediátrica em um ambulatório terciário.

Orientadora: Dra Elizete Aparecida Lomazi

Local onde será realizado: Ambulatório de Gastropediatria - UNICAMP.

CAMPINAS

2026

1) Dados dos participantes:

1) Júlia Jodjahn Figueiredo

Médica residente 2º ano do Programa de residência em Gastroenterologia e Hepatologia pediátricas.

Telefone para contato: (19)98196-4476

Local de trabalho: HC UNICAMP.

Endereço: Avenida Adelaide Spiandorello Brum, 255, Mirante de Jundiaí, Jundiaí - SP.

Currículo plataforma lattes: <https://lattes.cnpq.br/9927511878682928>

2) Elizete Aparecida Lomazi

Professora livre-docente Faculdade de Ciências médicas UNICAMP.

Supervisora do Programa de residência em Gastroenterologia e Hepatologia pediátricas.

Telefone para contato: (19)99122-6102

Local de trabalho: HC UNICAMP

Endereço: Rua Alexander Fleming, Distrito de Barão Geraldo, 13084970 - Campinas, SP - Brasil

Currículo plataforma lattes: <http://lattes.cnpq.br/1026340527527983>

2) Resumo informativo:

As doenças inflamatórias intestinais (DII), representadas pela Doença de Crohn e pela Retocolite Ulcerativa, são doenças crônicas imunomediadas que apresentam aumento de incidência na população pediátrica nos últimos anos. Nessa faixa etária, a apresentação clínica pode ser heterogênea e frequentemente inespecífica, incluindo manifestações intestinais, como dor abdominal, diarreia e sangramento gastrointestinal, além de manifestações extraintestinais, como atraso do crescimento, anemia, atraso puberal e manifestações articulares, cutâneas, oculares ou hepatobiliares. O reconhecimento tardio dessas manifestações pode contribuir para o atraso no diagnóstico, estando associado a maior risco de complicações, pior controle da atividade inflamatória e impacto negativo no crescimento e desenvolvimento dos pacientes. Portanto, a identificação das manifestações clínicas iniciais relacionadas ao tempo até o diagnóstico é fundamental para otimizar o manejo e o prognóstico dos pacientes pediátricos com DII. O presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre as manifestações clínicas iniciais e o tempo até o diagnóstico da Doença Inflamatória Intestinal em pacientes pediátricos acompanhados no ambulatório de Gastroenterologia Pediátrica da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Como objetivos específicos, pretende-se identificar as principais manifestações clínicas apresentadas pelos pacientes, avaliar o intervalo entre o início dos sintomas e o diagnóstico definitivo, além de comparar esse intervalo entre os diferentes subtipos de DII, incluindo Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa. Trata-se de um estudo retrospectivo, observacional e analítico, realizado por meio da revisão de prontuários médicos de pacientes pediátricos com

diagnóstico confirmado de DII, acompanhados em serviço terciário de Gastroenterologia Pediátrica. Serão incluídos pacientes com idade inferior a 18 anos no momento do diagnóstico, com confirmação diagnóstica por avaliação endoscópica e/ou colonoscópica associada à análise histopatológica, com seguimento ativo entre os anos 2024 a 2026. Serão coletados dados demográficos, classificação da doença, manifestações clínicas iniciais, data de início dos sintomas, data do diagnóstico e método diagnóstico utilizado. A análise dos dados será realizada por meio da avaliação descritiva das características clínicas e demográficas da população estudada, com cálculo do tempo até o diagnóstico em meses. Serão realizadas análises comparativas entre os grupos de pacientes conforme tipo de manifestação inicial e subtipo da doença, com o objetivo de identificar possíveis associações entre características clínicas iniciais e maior atraso no diagnóstico. O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas por meio da Plataforma Brasil, sendo realizada a aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos responsáveis legais dos participantes, garantindo a participação voluntária e o esclarecimento quanto aos objetivos, procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa. Espera-se que os resultados deste estudo contribuam para uma melhor compreensão dos padrões de apresentação inicial da Doença Inflamatória Intestinal na população pediátrica, permitindo identificar manifestações associadas a maior tempo até o diagnóstico. Dessa forma, o estudo poderá auxiliar na sensibilização dos profissionais de saúde quanto aos sinais de alerta da doença, favorecendo o encaminhamento precoce para avaliação especializada e contribuindo para a melhoria da assistência e dos desfechos clínicos desses pacientes.

3) Relevância social

A relevância social deste estudo está relacionada à possibilidade de ampliar o conhecimento sobre as manifestações clínicas iniciais da Doença Inflamatória Intestinal em pacientes pediátricos e quais são os fatores associados ao atraso diagnóstico. A identificação de padrões de apresentação clínica que possam estar relacionados a maior tempo até o diagnóstico pode contribuir para o reconhecimento precoce da doença por profissionais de saúde, favorecendo o encaminhamento

oportuno para avaliação especializada e o início adequado do tratamento. Dessa forma, os resultados poderão auxiliar na melhoria da assistência prestada a crianças e adolescentes com DII, com potencial impacto na redução de complicações, preservação do crescimento e desenvolvimento e melhora da qualidade de vida desses pacientes.

SUMÁRIO

1) Introdução	7
2) Objetivos	8
3) Hipóteses	9
4) Local de realização de pesquisa	10
5) População a ser estudada	10
6) Garantias éticas aos participantes da pesquisa	10
7) Método a ser utilizado	11
8) Cronograma	11
9) Orçamento	12
10) Critérios de inclusão e exclusão dos participantes da pesquisa	12
11) Riscos e benefícios envolvidos na execução da pesquisa	13
12) Resultados dos estudos	14
13) Referências bibliográficas	14

1) Introdução

As doenças inflamatórias intestinais (DII) são distúrbios crônicos imunomediados que incluem a doença de Crohn (DC) e a colite ulcerativa (CU), resultantes de uma resposta imune desregulada da mucosa à microbiota intestinal em indivíduos geneticamente predispostos (ROSEN et al. 2015). Aproximadamente 10% de todos os casos de DII têm início na faixa etária pediátrica, com incidência crescente nos últimos anos (BOUHUYS et al. 2023).

As manifestações clínicas iniciais mais comuns incluem dor abdominal, diarreia, hematoquezia ou enterorragia e perda de peso involuntária. Contudo, cerca de 22% das crianças apresentam manifestações atípicas como sintoma inicial, tais como falha de crescimento, atraso puberal, anemia, doença perianal e manifestações extraintestinais isoladas (articulares, cutâneas, oculares ou hepatobiliares) (BOUHUYS et al. 2023; ROSEN et al. 2015). A DC pode acometer qualquer área do trato gastrointestinal, sendo mais comum o envolvimento ileocolônico, enquanto a CU é tipicamente restrita ao cólon, com pancolite sendo a apresentação mais frequente em crianças (ROSEN et al. 2015; BOUSVAROS et al., 2007).

O atraso diagnóstico representa um desafio significativo na DII pediátrica. Estudos recentes demonstram que o atraso diagnóstico mediano é de 4 a 5 meses para DC e 2 a 3 meses para CU, sendo consistentemente maior para Crohn do que para colite ulcerativa. Uma revisão sistemática recente, com mais de 7.000 crianças, confirma esses valores e destaca que a maioria dos estudos reporta intervalos de 4–6 meses para DC e 2–3 meses para CU (VERNON-ROBERTS et al., 2023).

Além disso, há evidências crescentes de que o acometimento ileal está associado ao maior risco de atraso na confirmação diagnóstica da DC, uma vez que esses pacientes apresentam menor probabilidade de desenvolver sintomas de alarme, tais quais sangramento nas fezes (ZAHARIE et al., 2016).

Esse atraso é composto por dois períodos principais: o tempo entre o início dos sintomas e a primeira consulta médica, e o tempo entre a consulta médica e o diagnóstico endoscópico. O maior componente do atraso geralmente ocorre antes

da primeira consulta médica, especialmente em casos com sintomas menos específicos (CHOI et al., 2026).

A ausência de biomarcadores confiáveis e não invasivos para rastreamento pré-clínico na população geral representa outra causa de apresentação tardia. A calprotectina fecal é um marcador de inflamação intestinal amplamente utilizado no diagnóstico diferencial. No entanto, seus níveis também podem estar elevados em outras condições, como infecções gastrointestinais, gastrite, pólipos ou diverticulite, além de sofrerem influência do uso crônico de medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais. Dessa forma, frequentemente, existe um longo período entre o início assintomático da doença e a primeira consulta médica, que habitualmente ocorre apenas diante da progressão do quadro e do surgimento de complicações (MINEA et al., 2025).

Por outro lado, quando os pacientes apresentam formas leves da doença, podem não perceber a necessidade de avaliação médica urgente. Barreiras de acesso à saúde — como dificuldades logísticas, limitações financeiras e longos tempos de espera — também impactam esses pacientes de maneira semelhante (MINEA et al., 2025).

O atraso diagnóstico está associado a desfechos adversos significativos, incluindo maior risco de complicações estruturantes e penetrantes na DC, necessidade de cirurgia e comprometimento do crescimento linear que pode persistir mesmo após o diagnóstico (BOUHUYS et al., 2023; VAN LIMBERGEN et al., 2018).

O enfrentamento desses desafios requer uma abordagem multifatorial, que inclua o aprimoramento das ferramentas de triagem na atenção primária — como o uso combinado de sintomas, marcadores sanguíneos e calprotectina fecal —, a melhoria da capacitação dos médicos generalistas para reconhecimento precoce de sinais de alarme, e a otimização dos fluxos de encaminhamento para centros especializados (RICCIUTO et al., 2018; SULKANEN et al., 2021).

2) Objetivos

2.1 Objetivo geral:

Analisar a relação entre as manifestações clínicas iniciais e o tempo até o diagnóstico da Doença Inflamatória Intestinal em pacientes pediátricos atendidos no ambulatório de gastroenterologia pediátrica da UNICAMP.

2.2 Objetivos específicos:

- Identificar as principais manifestações clínicas iniciais apresentadas pelos pacientes;
- Avaliar o intervalo de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico da Doença Inflamatória Intestinal;
- Analisar a associação entre tipos de manifestações clínicas iniciais (intestinais ou extraintestinais) e o tempo até o diagnóstico;
- Comparar o tempo até o diagnóstico entre Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa;

3) Hipóteses

Hipótese geral: Pacientes pediátricos com Doença Inflamatória Intestinal que apresentam manifestações clínicas iniciais menos específicas ou manifestações extraintestinais apresentam maior tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico definitivo da doença.

Hipótese 1: As principais manifestações clínicas iniciais dos pacientes pediátricos com Doença Inflamatória Intestinal são predominantemente sintomas gastrointestinais, porém manifestações extraintestinais e sinais como alteração do crescimento podem estar presentes como apresentação inicial da doença.

Hipótese 2: Existe intervalo significativo entre o início das manifestações clínicas e o diagnóstico definitivo da Doença Inflamatória Intestinal em pacientes pediátricos acompanhados em serviço terciário de referência.

Hipótese 3: Pacientes que apresentam manifestações clínicas iniciais extraintestinais ou ausência de sintomas gastrointestinais típicos apresentam maior

tempo até o diagnóstico quando comparados àqueles com manifestações intestinais clássicas.

Hipótese 4: O tempo até o diagnóstico é maior em pacientes pediátricos com Doença de Crohn quando comparado aos pacientes com Retocolite Ulcerativa.

4) Local de realização de pesquisa

O estudo será conduzido no Ambulatório de Gastroenterologia Pediátrica da UNICAMP, serviço de referência terciária para o acompanhamento de pacientes com doenças gastrointestinais crônicas na infância e adolescência.

5) População a ser estudada

Serão incluídos pacientes pediátricos, idade inferior a 18 anos no momento do diagnóstico, com seguimento ativo entre os anos de 2024 a 2026, com diagnóstico de Doença Inflamatória Intestinal, incluindo Colite não especificada, Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa, acompanhados no referido ambulatório.

6) Garantias éticas aos participantes da pesquisa

A participação na pesquisa será voluntária, sendo garantida aos participantes e seus responsáveis legais a liberdade de recusar ou retirar o consentimento em qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao acompanhamento ou à assistência médica prestada pela instituição. Antes da inclusão dos dados no estudo, será aplicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), contendo informações sobre os objetivos, procedimentos, possíveis riscos e benefícios da pesquisa, assegurando o esclarecimento de todas as dúvidas dos participantes e responsáveis.

Os dados coletados a partir dos prontuários médicos serão utilizados exclusivamente para os objetivos desta pesquisa, sendo preservada a identidade dos participantes. As informações serão registradas em banco de dados, sem utilização de nome, número de registro hospitalar ou qualquer dado que permita identificação direta dos pacientes. O acesso às informações será restrito aos

pesquisadores envolvidos no estudo, garantindo a privacidade, o sigilo e a confidencialidade dos dados.

Os dados obtidos serão armazenados de forma segura, em ambiente protegido, e utilizados exclusivamente para fins científicos. Os resultados poderão ser divulgados em trabalhos acadêmicos e publicações científicas, porém sem qualquer informação que possibilite a identificação individual dos participantes.

7) Método a ser utilizado

Trata-se de um estudo retrospectivo, observacional e analítico, que será realizado a partir da análise de dados de prontuários médicos de pacientes pediátricos com diagnóstico de Doença Inflamatória Intestinal (DII), acompanhados em ambulatório terciário de gastroenterologia pediátrica.

7.2 Coleta de dados

A coleta de dados será realizada por meio da revisão sistemática dos prontuários médicos, utilizando formulário padronizado previamente elaborado. Serão coletadas as seguintes variáveis:

1. Dados demográficos (idade e sexo);
2. Tipo de Doença Inflamatória Intestinal (Colite Indeterminada, Doença de Crohn ou Retocolite Ulcerativa);
3. Manifestações clínicas iniciais, incluindo sintomas intestinais e extraintestinais;
4. Data referida de início dos sintomas;
5. Data do diagnóstico da Doença Inflamatória Intestinal;
6. Método diagnóstico utilizado, com ênfase na confirmação endoscópica e histopatológica.

O tempo até o diagnóstico foi definido como o intervalo, em meses, entre a data de início das manifestações clínicas iniciais e a data do diagnóstico definitivo da doença.

8) Cronograma

Cronograma de execução do projeto

Junho a Julho de 2026: Revisão bibliográfica, elaboração e adequação final do projeto de pesquisa, submissão do projeto à Plataforma Brasil e encaminhamento ao Comitê de Ética em Pesquisa.

Julho a Agosto de 2026: Aguardar avaliação ética, realizar ajustes solicitados pelo Comitê de Ética em Pesquisa, obtenção da aprovação ética e organização dos instrumentos de coleta de dados.

Agosto a Novembro de 2026: Coleta de dados por meio da revisão dos prontuários médicos dos pacientes incluídos no estudo, preenchimento do banco de dados e conferência das informações coletadas.

Novembro a Dezembro de 2026: Organização, análise estatística e interpretação dos dados obtidos, com elaboração dos resultados do estudo.

Dezembro de 2026 a Janeiro de 2027: Redação do Trabalho de Conclusão de Curso, elaboração da discussão dos resultados, revisão final do texto e preparação da apresentação.

Fevereiro de 2027: Apresentação e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso.

Após fevereiro de 2027: Adequação do manuscrito conforme normas editoriais e preparação para submissão do estudo a periódico científico.

9) Orçamento

A presente pesquisa não apresenta custos adicionais previstos. Os procedimentos envolvidos consistem na análise retrospectiva de prontuários médicos e organização dos dados coletados, utilizando recursos já disponíveis na instituição e pelos pesquisadores envolvidos. Não haverá necessidade de aquisição de materiais, contratação de serviços ou financiamento externo para a realização do estudo.

10) Critérios de inclusão e exclusão dos participantes da pesquisa

10.1 Critérios de inclusão

Serão incluídos no estudo pacientes que preencheram os seguintes critérios:

- Idade inferior a 18 anos no momento do diagnóstico;
- Diagnóstico de Doença Inflamatória Intestinal confirmado por colonoscopia e/ou endoscopia digestiva alta com biópsia;
- Acompanhamento no ambulatório de gastroenterologia pediátrica da UNICAMP;
- Disponibilidade de dados clínicos suficientes nos prontuários eletrônicos para análise das manifestações clínicas iniciais e das datas de início dos sintomas e do diagnóstico.

10.2 Critérios de exclusão

Serão excluídos pacientes com prontuários eletrônicos incompletos, que não permitam a determinação do intervalo entre o início das manifestações clínicas e o diagnóstico, bem como aqueles cujo diagnóstico não foi confirmado por avaliação endoscópica/colonoscópica com biópsia.

Também serão excluídos pacientes que perderam seguimento no ambulatório de gastroenterologia pediátrica, seja por transição para o ambulatório de adultos ou por interrupção do acompanhamento na instituição.

11) Riscos e benefícios envolvidos na execução da pesquisa

A pesquisa apresenta risco mínimo aos participantes, uma vez que será realizada por meio de análise retrospectiva de prontuários médicos, sem realização de procedimentos adicionais. O principal risco está relacionado à possibilidade de quebra de confidencialidade das informações. Para minimizar esse risco, os dados serão codificados, utilizados exclusivamente para os objetivos do estudo e

acessados apenas pelos pesquisadores envolvidos, garantindo privacidade e sigilo dos participantes.

Não são esperados benefícios diretos aos participantes. Como benefício indireto, o estudo poderá contribuir para o melhor entendimento das manifestações iniciais da Doença Inflamatória Intestinal em pacientes pediátricos, favorecendo o diagnóstico precoce, o encaminhamento adequado e a melhoria da assistência prestada a essa população.

12) Resultados dos estudos

Os resultados da pesquisa serão divulgados aos participantes e às instituições envolvidas, quando solicitado, por meio da apresentação dos achados gerais do estudo. A divulgação dos resultados ocorrerá de forma agregada, sem exposição de informações que permitam a identificação individual dos participantes, preservando a confidencialidade dos dados. Os resultados também poderão ser apresentados em eventos científicos e publicados em periódicos acadêmicos.

13) Referências bibliográficas

1. BOUSVAROS, A. *et al.* Differentiating ulcerative colitis from Crohn disease in children and young adults: report of a working group of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the Crohn's and Colitis Foundation of America. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, v. 44, n. 5, p. 653-674, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e31805563f3>. Acesso em: 06 jun 2026.
2. BOUHUYS, M. *et al.* Pediatric inflammatory bowel disease. *Pediatrics*, v. 151, n. 1, e2022058037, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1542/peds.2022-058037>. Acesso em 05 mai. 2026.
3. CHOI, S. Y. *et al.* "Delays in Diagnosing Pediatric Inflammatory Bowel Disease in Korea: Impact on Disease Severity and the Need for Early Recognition." *Journal of Korean medical science* vol. 41,7 e73. 23 Feb. 2026, doi:10.3346/jkms.2026.41.e73. Acesso em: 10 jun 2026

4. MINEA, H. et al. Patient and physician factors contributing to delays in inflammatory bowel diseases: enhancing timely diagnosis. *World Journal of Gastroenterology*, v. 31, n. 6, p. 100295, 2025. DOI: 10.3748/wjg.v31.i6.100295. Acesso em: 18 jun 2026
5. RICCIUTO, A. et al. Diagnostic delay in Canadian children with inflammatory bowel disease is more common in Crohn's disease and is associated with decreased height. *Archives of Disease in Childhood*, v. 103, n. 4, p. 319–326, 2018. DOI: 10.1136/archdischild-2017-313030. Acesso em: 05 jun 2026
6. ROSEN, M. J. et al. Inflammatory bowel disease in children and adolescents. *JAMA Pediatrics*, v. 169, n. 11, p. 1053–1060, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2015.1982>. Acesso em: 08 jun 2026
7. SULKANEN, H. et al. Impact of diagnostic delay on the clinical presentation and associated factors in pediatric inflammatory bowel disease. *BMC Gastroenterology*, v. 21, n. 1, p. 1–9, 2021. DOI: 10.1186/s12876-021-01938-8. Acesso em: 05 jun 2026
8. VAN LIMBERGEN, J. et al. Definition of phenotypic characteristics of childhood-onset inflammatory bowel disease. *Gastroenterology*, v. 154, n. 3, p. 589–598, 2018. DOI: 10.1053/j.gastro.2017.10.023. Acesso em: 06 jun 2026
9. VERNON-ROBERTS, A. et al. Systematic review of diagnostic delay for children with inflammatory bowel disease. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, v. 76, n. 3, p. 304–312, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000003670>. Acesso em: 06 jun 2026
10. ZAHARIE, R. et al. Diagnostic delay in Romanian patients with inflammatory bowel disease: risk factors and impact on the disease course and need for surgery. *Journal of Crohn's and Colitis*, v. 10, n. 3, p. 306–314, 2016. DOI: 10.1093/ecco-jcc/jjv215. Acesso em: 06 jun 2026